HLAVNÍ MATERIÁL

12týdenní studijní plán stáže

30–45 minut denně, šest dní v týdnu. Od fyziky po multimodální případy: každý týden jeden cíl, pět případů a krátké sebehodnocení; abyste přišli připraveni na každou stáž a každou vizitu.

Obsah

Jak tento plán používat

Opakování v druhém období

Týden 1 · Fyzikální abeceda a terminologie

Týden 2 · RTG plic

Týden 3 · RTG břicha a muskuloskeletální snímky

Týden 4 · CT mozku

Týden 5 · CT hrudníku

Týden 6 · CT břicha

Týden 7 · MR mozku a páteře

Týden 8 · Muskuloskeletální MR a MR břicha

Týden 9 · UZ břicha a povrchových struktur

Týden 10 · Doppler a POCUS

Týden 11 · Multimodální zobrazení a urgentní stavy

Týden 12 · Celkové opakování a simulace vizity

Další krok

ÚVODEM

Jak tento plán používat

Dostatečně krátké na to, aby se dalo zvládnout i během náročných týdnů ve službě, a dostatečně strukturované, aby vás provedlo celým rokem.

> *V předatestační přípravě nerozhoduje jedna dlouhá probdělá noc nad učením, ale krátké a pravidelné opakování každý den ve stejnou dobu.*

Rytmus týdne

DEN	ČAS	CO UDĚLÁTE
Pondělí–pátek	30–45 min	Téma dne: přečtěte si příslušný svazek, vyhledejte korelát v atlasu, vyřešte jeden z případů.
Sobota	30–45 min	Zbývající případy týdne a víkendové sebehodnocení.
Neděle	—	Odpočinek. Pokud jste během týdne zameškali den kvůli službě, využijte jej jako náhradní den.

U každého případu stejné 4 kroky

1. **PŘIPRAVTE** — Identifikujte (pacient, vyšetření, datum, protokol), zkontrolujte kvalitu (technická dostatečnost), zorientujte se (strana, řez, okno nebo sekvence).
2. **PROJDĚTE** — Projděte každou oblast pokaždé ve stejném pořadí. Nezastavujte se u prvního nálezu.
3. **POPIŠTE** — Popište správnou terminologií (denzita / signál / echogenita), lokalizací, velikostí a ohraničením; porovnejte s předchozím vyšetřením a kontralaterální stranou.
4. **SHRŇTE** — Napište závěr popisu, diferenciální diagnózu a doporučení. Pokud je přítomen urgentní nález, nezapomeňte jej nahlásit.

Mějte Cvičebnici při sobě

Na konci každého případu si do Cvičebnice zapište tři řádky: co jste viděli, jaký termín jste použili a jaký je váš závěr popisu. Na konci týdne budou tyto řádky vašimi nejcennějšími poznámkami k opakování.

Přizpůsobte program své stáži

- Pořadí týdnů je doporučené. Pokud jste právě na neuroradiologické stáži, můžete přesunout Týden 4 a Týden 7 dopředu; ostatní týdny pokračují ve svém pořadí.
- Případy postupují podle obtížnosti. I když změníte pořadí týdnů, vyřešte pět případů každého týdne společně s daným týdnem.
- Ve dnech po službě zkraťte čas na 30 minut, ale plán nepřerušujte. Krátké, ale pravidelné studium je trvalejší než dlouhé, ale nepravidelné.
- Zaznamenejte si svůj pokrok do Týdenního přehledu sledování pokroku.

DRUHÁ POLOVINA ROKU

Opakování v druhém období

Až dokončíte 12 týdnů, začněte cyklus znovu; druhé kolo bude rychlejší a selektivnější.

1. **Rychlejší druhý průchod.** Zkraťte teoretické čtení; hlavní čas věnujte případům a vlastním popisům.
2. **Nejprve vyřešte to, co se vám nepodařilo vyřešit dříve.** Případy, které jste v kontrolním archu neoznačili nebo se kterými jste měli potíže, zařaďte na začátek každého týdne.
3. **Měřte si čas.** Každý případ vyřešte před nahlédnutím do odpovědi se stopkami a zaznamenejte si čas. Cílem není spěchat, ale zautomatizovat si stálý postup.
4. **Upravte pořadí podle stáže.** V závislosti na tom, na jaké stáži v druhé polovině roku jste, přesuňte příslušné týdny dopředu.
5. **Přidejte přehlédnuté případy.** Čísla ze 100 praktických případů, která nebyla zařazena do prvního kola, rozvrhněte v druhém kole do jednotlivých týdnů; na konci roku tak budete mít vyřešeno všech sto případů.
6. **Prezentujte nahlas.** Shrňte každý případ nahlas za 60 sekund, jako byste jej prezentovali na vizitě.

> **Kritérium druhého kola**
>
> Pokud dokážete tentýž případ prezentovat za kratší dobu než v prvním kole, s méně nedostatky a jasnějším závěrem popisu, jste na správné cestě.

TÝDEN 1

Fyzikální abeceda a terminologie

Osvojte si, jak obraz vzniká a jakými slovy jej správně popsat.

Cíl týdne

Dokázat vysvětlit, proč vzniká jas na RTG, CT, MR a UZ, a v každé modalitě používat správný termín (opacita, denzita, signál, echogenita).

DEN	ČAS	ÚKOL	MATERIÁL
Po	30–45 min	Vznik obrazu na RTG a CT; zeslabení a koncept HU.	Svazek 01 · Fyzikální abeceda
Út	30–45 min	Základy MR: obecné principy sekvencí T1, T2, FLAIR a DWI.	Svazek 01 · Fyzikální abeceda
Stř	30–45 min	Základy UZ: echogenita, akustický stín, dorzální akustické zesílení.	Svazek 01 · Fyzikální abeceda
Čt	30–45 min	Termíny a zkratky podle modalit; často zaměňované pojmy.	Abeceda obrazu
Pá	30–45 min	Čtení 4krokové metody; Případ 1–3.	Průvodce interpretací snímků · 100 praktických případů
So	30–45 min	Případy 4–5 a sebehodnocení; zapište si termíny do sešitu.	100 praktických případů · Cvičebnice

5 případů tohoto týdne (100 praktických případů)

Případ 1 · Případ 2 · Případ 3 · Případ 4 · Případ 5

Víkendové sebehodnocení

- [ ] Dokážu vysvětlit, proč vzduch, tuk, měkké tkáně, kost a kov vypadají na RTG a CT odlišně.
- [ ] Dokážu správně přiřadit termíny hyperdenzní, hyperintenzní a hyperechogenní k příslušné modalitě.
- [ ] Dokážu říct, jak vypadá tekutina na T1- a T2-vážených obrazech.
- [ ] Dokážu uvést, co akustický stín značí, a uvést příklad.
- [ ] Dokážu zpaměti a popořadě vyjmenovat 4 kroky (PŘIPRAVTE · PROJDĚTE · POPIŠTE · SHRŇTE).

TÝDEN 2

RTG hrudníku

Stálý postup čtení pro vyšetření, se kterým se ve službě setkáte nejčastěji.

Cíl týdne

Hodnotit PA a lůžkový RTG plic pokaždé ve stejném pořadí; nepřehlédnout pneumotorax, výpotek, konsolidaci a polohu tubusů a katétrů.

DEN	ČAS	ÚKOL	MATERIÁL
Po	30–45 min	Technická kvalita (rotace, inspirium, penetrace) a normální anatomie.	Svazek 02 · RTG
Út	30–45 min	Pevné pořadí prohlížení; Případ 9.	Svazek 02 · RTG · 100 praktických případů
Stř	30–45 min	Konsolidace, atelektáza, výpotek; porovnejte v atlasu. Případ 10.	Atlas nejčastějších nálezů
Čt	30–45 min	Pneumotorax, kardiomegalie, plicní edém. Případ 11.	Svazek 02 · Atlas nejčastějších nálezů
Pá	30–45 min	Poloha kanyl, katétrů a drénů; Případ 12.	Svazek 02 · Průvodce interpretací snímků
So	30–45 min	Případ 13, sebehodnocení, šablona popisu RTG hrudníku.	Cvičebnice

5 případů tohoto týdne (100 praktických případů)

Případ 9 · Případ 10 · Případ 11 · Případ 12 · Případ 13

Víkendové sebehodnocení

- [ ] Dokážu zhodnotit technickou kvalitu RTG hrudníku ve třech bodech.
- [ ] Dokážu říct svůj postup prohlížení bez nahlížení do papíru.
- [ ] Dokážu vyjmenovat nálezy odlišující konsolidaci od atelektázy.
- [ ] U pneumotoraxu dokážu popsat linii viscerální pleury a známky tenzního pneumotoraxu.
- [ ] Do svého postupu jsem přidal(a) kontrolu polohy endotracheální kanyly a hrotu centrálního žilního katétru.

TÝDEN 3

RTG snímky břicha a muskuloskeletálního systému

Zachycení přehlédnutých nálezů při hodnocení nativního snímku břicha a fraktur.

Cíl týdne

Rozpoznat známky volného plynu a obstrukce; popsat frakturu podle lokalizace, typu a dislokace a aplikovat pravidlo dvou projekcí.

DEN	ČAS	ÚKOL	MATERIÁL
Po	30–45 min	Pevné pořadí na nativním snímku břicha: distribuce plynu, volný vzduch, kalcifikace.	Svazek 02 · RTG
Út	30–45 min	Obstrukce tenkého a tlustého střeva, volvulus; Případ 18.	Atlas nejčastějších nálezů · 100 praktických případů
Stř	30–45 min	Terminologie popisu zlomenin; horní končetina. Případ 19.	Svazek 02 · Abeceda obrazu
Čt	30–45 min	Dolní končetina, kyčel, luxace; Případ 20.	Svazek 02 · Atlas nejčastějších nálezů
Pá	30–45 min	Pediatrické zlomeniny a cizí těleso; Případ 21.	Svazek 02 · Průvodce interpretací snímků
So	30–45 min	Případ 22, sebehodnocení, popisné fráze pro fraktury.	Cvičebnice

5 případů tohoto týdne (100 praktických případů)

Případ 18 · Případ 19 · Případ 20 · Případ 21 · Případ 22

Víkendové sebehodnocení

- [ ] Dokážu popsat volný vzduch pod bránicí a vysvětlit, v jaké poloze se hledá.
- [ ] Dokážu vyjmenovat známky odlišující dilataci tenkého a tlustého střeva.
- [ ] Dokážu popsat zlomeninu podle kosti, lokalizace, typu linie, dislokace a kloubního postižení.
- [ ] Dokážu vysvětlit, proč nelze z jediné projekce vyloučit frakturu.
- [ ] Při hodnocení fraktur u dětí navíc kontroluji růstovou ploténku.

TÝDEN 4

CT mozku

Nejkritičtější vyšetření ve službě: nepřehlédnout krvácení, iktus a expanzivní efekt.

Cíl týdne

Hodnotit nativní CT mozku v mozkovém, iktovém a kostním okně ve stálém pořadí; rozpoznat typy krvácení a časné známky ischemie.

DEN	ČAS	ÚKOL	MATERIÁL
Po	30–45 min	Okna a normální anatomie; stálý postup hodnocení.	Svazek 03 · CT
Út	30–45 min	Epidurální, subdurální, subarachnoidální a intracerebrální krvácení. Případ 26.	Atlas nejčastějších nálezů · 100 praktických případů
Stř	30–45 min	Ischemická CMP: časné nálezy, hyperdenzní arterie. Případ 27.	Svazek 03 · CT
Čt	30–45 min	Expanzivní efekt, přesun středočárových struktur, hydrocefalus, herniace. Případ 28.	Svazek 03 · Průvodce interpretací snímků
Pá	30–45 min	Kalva a baze lební v kostním okně; dutiny. Případ 29.	Svazek 03 · CT
So	30–45 min	Případ 30, sebehodnocení, šablona popisu CT mozku.	Cvičebnice

5 případů tohoto týdne (100 praktických případů)

Případ 26 · Případ 27 · Případ 28 · Případ 29 · Případ 30

Víkendové sebehodnocení

- [ ] Dokážu odlišit epidurální a subdurální hematom podle tvaru a charakteru ohraničení.
- [ ] Dokážu vyjmenovat, na která místa se při subarachnoidálním krvácení zaměřit.
- [ ] Dokážu popsat časné známky ischémie a vysvětlit, proč se používá iktové okno.
- [ ] Dokážu v popisu uvést nálezy svědčící pro expanzivní efekt ve správném pořadí.
- [ ] U žádného CT mozku nevynechávám kostní okno.

TÝDEN 5

CT hrudníku

Systematické čtení v plicním a mediastinálním okně; urgentní stavy hrudníku.

Cíl týdne

Hodnotit CT hrudníku v plicním, mediastinálním a kostním okně; rozpoznat urgentní nálezy jako plicní embolie, disekce aorty a pneumotorax a správně popsat uzel.

DEN	ČAS	ÚKOL	MATERIÁL
Po	30–45 min	Okna, normální anatomie mediastina, stálý postup.	Svazek 03 · CT
Út	30–45 min	CT angiografie pro plicní embolii: kontrastní fáze a defekt náplně. Případ 35.	Svazek 03 · 100 praktických případů
Stř	30–45 min	Disekce aorty a aneuryzma. Případ 36.	Atlas nejčastějších nálezů
Čt	30–45 min	Uzel, expanze, mléčné sklo, emfyzém: popisná terminologie. Případ 37.	Svazek 03 · Abeceda obrazu
Pá	30–45 min	Pneumotorax, výpotek, trauma hrudníku. Případ 38.	Svazek 03 · Průvodce interpretací snímků
So	30–45 min	Případ 39, sebehodnocení, šablona popisu CT hrudníku.	Cvičebnice

5 případů tohoto týdne (100 praktických případů)

Případ 35 · Případ 36 · Případ 37 · Případ 38 · Případ 39

Víkendové sebehodnocení

- [ ] Kontroluji, zda je vyšetření pro plicní embolii dostatečně vysyceno kontrastní látkou.
- [ ] Vím, jak popsat intimální flap a rozsah postižení u disekce aorty.
- [ ] Dokážu popsat nodul podle velikosti, denzity, ohraničení a lokalizace.
- [ ] Dokážu vysvětlit rozdíl mezi matnicí a konsolidací.
- [ ] U každého CT hrudníku kontroluji, zda jsem prošel všechna tři okna.

TÝDEN 6

CT břicha

Časté příčiny náhlé příhody břišní a správné použití kontrastních fází.

Cíl týdne

Postupovat při CT břicha orgán po orgánu ve fixním pořadí; rozpoznat apendicitidu, divertikulitidu, obstrukci, volný plyn, litiázu a poranění orgánů po traumatu.

DEN	ČAS	ÚKOL	MATERIÁL
Po	30–45 min	Kontrastní fáze (arteriální, portovenózní, pozdní) a postup hodnocení.	Svazek 03 · CT
Út	30–45 min	Apendicitida a divertikulitida. Případ 44.	Atlas nejčastějších nálezů · 100 praktických případů
Stř	30–45 min	Střevní obstrukce a pneumoperitoneum. Případ 45.	Svazek 03 · CT
Čt	30–45 min	Ureterolitiáza, pankreatitida, cholecystitida. Případ 46.	Svazek 03 · Průvodce interpretací snímků
Pá	30–45 min	Poranění parenchymatózních orgánů při traumatu; terminologie jaterních lézí. Případ 47.	Svazek 03 · Abeceda obrazu
So	30–45 min	Případ 48, sebehodnocení, šablona popisu CT břicha.	Cvičebnice

5 případů tohoto týdne (100 praktických případů)

Případ 44 · Případ 45 · Případ 46 · Případ 47 · Případ 48

Víkendové sebehodnocení

- [ ] V prvním kroku určuji, v jaké kontrastní fázi bylo vyšetření provedeno.
- [ ] Dokážu vyjmenovat svůj postup hodnocení CT břicha orgán po orgánu.
- [ ] Zvykl jsem si hledat volný plyn ve vhodném okně.
- [ ] Dokážu vypsat nálezy, které musí být uvedeny v popisu u apendicitidy a divertikulitidy.
- [ ] Do závěru popisu přidávám, že je nutné urgentní nález nahlásit ošetřujícímu lékaři a mému školiteli.

TÝDEN 7

MR mozku a páteře

Rozpoznat sekvence a vědět, co která z nich zobrazuje.

Cíl týdne

Rozpoznat sekvence T1, T2, FLAIR, DWI a postkontrastní série; popsat akutní infarkt, demyelinizační plaku, expanzi a kompresi míchy.

DEN	ČAS	ÚKOL	MATERIÁL
Po	30–45 min	Rozpoznávání sekvencí: signál tekutiny, tuku a krve.	Svazek 04 · MR · Svazek 01 · Fyzikální abeceda
Út	30–45 min	DWI a akutní infarkt. Případ 52.	Svazek 04 · 100 praktických případů
Stř	30–45 min	Léze bílé hmoty a plaky MS. Případ 53.	Atlas nejčastějších nálezů
Čt	30–45 min	Léze: intraaxiální a extraaxiální rozlišení, sycení. Případ 54.	Svazek 04 · Abeceda obrazu
Pá	30–45 min	Páteř: hernie disku a komprese míchy. Případ 55.	Svazek 04 · Průvodce interpretací snímků
So	30–45 min	Případ 56, sebehodnocení, šablona popisu MR.	Cvičebnice

5 případů tohoto týdne (100 praktických případů)

Případ 52 · Případ 53 · Případ 54 · Případ 55 · Případ 56

Víkendové sebehodnocení

- [ ] Když otevřu sérii, dokážu podle signálu tekutiny poznat, o jakou sekvenci se jedná.
- [ ] Vím, že restrikci na DWI musím hodnotit společně s ADC mapou.
- [ ] Dokážu vyjmenovat znaky odlišující axiální a extraaxiální expanzi.
- [ ] Vím, že komprese míchy je urgentní nález k okamžitému hlášení, a vím, jak ji popsat.
- [ ] U MR používám slovo „signál“, nikoli „denzita“.

TÝDEN 8

Muskuloskeletální MR a MR břicha

Základní pořadí čtení MR kolene a ramene; časté léze jater a hypofýzy.

Cíl týdne

Postupné hodnocení vazů, menisků a šlach na MR kolene a ramene; identifikace častých benigních lézí jater a lézí hypofýzy.

DEN	ČAS	ÚKOL	MATERIÁL
Po	30–45 min	MR kolene: normální anatomie a pevné pořadí.	Svazek 04 · MR
Út	30–45 min	Ruptury předního zkříženého vazu a menisků. Případ 61.	Atlas nejčastějších nálezů · 100 praktických případů
Stř	30–45 min	MR ramene: rotátorová manžeta. Případ 62.	Svazek 04 · MR
Čt	30–45 min	MR jater: signálové charakteristiky hemangiomu a cysty. Případ 63.	Svazek 04 · Abeceda obrazu
Pá	30–45 min	Hypofýza a selární oblast; mozkový absces. Případ 64.	Svazek 04 · Průvodce interpretací snímků
So	30–45 min	Případ 65, sebehodnocení, formulace popisu muskuloskeletální MR.	Cvičebnice

5 případů tohoto týdne (100 praktických případů)

Případ 61 · Případ 62 · Případ 63 · Případ 64 · Případ 65

Víkendové sebehodnocení

- [ ] Dokážu vyjmenovat struktury hodnocené na MR kolene v pevném pořadí.
- [ ] Dokážu popsat signálovou změnu svědčící pro rupturu menisku.
- [ ] Dokážu jmenovitě vyjmenovat šlachy rotátorové manžety.
- [ ] Dokážu vysvětlit základní MR charakteristiky odlišující cystu od hemangiomu v játrech.
- [ ] Nejistý nález na MR formuluji s diferenciální diagnózou a doporučením, nikoli jako definitivní diagnózu.

TÝDEN 9

UZ břicha a povrchových struktur

Stálý postup se sondou v ruce: zobrazte každý orgán ve dvou rovinách.

Cíl týdne

Provádět systematické vyšetření jater, žlučníku, ledvin a povrchových orgánů; správnými termíny popsat žlučové kameny, cholecystitidu, hydronefrózu, cystu a uzel.

DEN	ČAS	ÚKOL	MATERIÁL
Po	30–45 min	Volba sondy, nastavení, pravidlo dvou rovin a postup vyšetření.	Svazek 05 · UZ/POCUS
Út	30–45 min	Játra: steatóza jater, cysta, absces. Případ 70.	Svazek 05 · 100 praktických případů
Stř	30–45 min	Žlučník: litiáza, cholecystitida. Případ 71.	Atlas nejčastějších nálezů
Čt	30–45 min	Ledviny: hydronefróza, prostá cysta. Případ 72.	Svazek 05 · Abeceda obrazu
Pá	30–45 min	Povrchové: uzel štítné žlázy, cysta prsu; UZ apendicitidy. Případ 73.	Svazek 05 · Průvodce interpretací snímků
So	30–45 min	Případ 74, sebehodnocení, šablona popisu UZ.	Cvičebnice

5 případů tohoto týdne (100 praktických případů)

Případ 70 · Případ 71 · Případ 72 · Případ 73 · Případ 74

Víkendové sebehodnocení

- [ ] Každý orgán hodnotím ve dvou rovinách a uvádím do popisu.
- [ ] Dokážu vyjmenovat UZ kritéria prosté cysty.
- [ ] Dokážu vysvětlit znaky odlišující žlučový konkrement od polypu (akustický stín, pohyblivost).
- [ ] Při popisu hydronefrózy hodnotím také kontralaterální ledvinu.
- [ ] Při UZ správně používám termíny pro «echogenitu».

TÝDEN 10

Doppler a POCUS

Cévní a urgentní bed-side UZ: rychle, cíleně, ve stejném pořadí.

Cíl týdne

Pochopit základní princip barevného Doppleru; rozpoznat DVT, torzi varlete a aneuryzma aorty; provádět eFAST a plicní UZ (linie A a B) v pevném pořadí.

DEN	ČAS	ÚKOL	MATERIÁL
Po	30–45 min	Základy Doppleru: barva, směr toku, časté artefakty.	Svazek 05 · UZ/POCUS · Svazek 01 · Fyzikální abeceda
Út	30–45 min	Venózní Doppler dolních končetin a DVT. Případ 78.	Svazek 05 · 100 praktických případů
Stř	30–45 min	Skrotální Doppler a torze; abdominální aorta. Případ 79.	Atlas nejčastějších nálezů
Čt	30–45 min	eFAST: projekce a volná tekutina. Případ 80.	Svazek 05 · Průvodce interpretací snímků
Pá	30–45 min	UZ plic, perikardiální výpotek, podezření na mimoděložní těhotenství. Případ 81.	Svazek 05 · UZ/POCUS
So	30–45 min	Případ 82, sebehodnocení, stručné formulace popisu POCUS.	Cvičebnice

5 případů tohoto týdne (100 praktických případů)

Případ 78 · Případ 79 · Případ 80 · Případ 81 · Případ 82

Víkendové sebehodnocení

- [ ] Při hodnocení HŽT používám kompresibilitu jako základní nález.
- [ ] Vím, že podezření na torzi varlete vyžaduje urgentní hlášení.
- [ ] Dokážu postupně vyjmenovat projekce eFAST.
- [ ] Dokážu vysvětlit, co znamenají linie A a linie B.
- [ ] V popisu uvádím, že negativní POCUS nemusí vždy vyloučit patologii.

TÝDEN 11

Multimodalita a urgentní stavy

Kombinace RTG, CT, MR a UZ u téhož pacienta; scénáře ze služeb.

Cíl týdne

Schopnost posoudit, které vyšetření je pro danou klinickou otázku vhodné; sjednotit nálezy z různých modalit do jednoho závěru popisu a včas nahlásit urgentní nález.

DEN	ČAS	ÚKOL	MATERIÁL
Po	30–45 min	Od klinické otázky k vyšetření: logika volby modality.	Svazek 06 · Multimodální případy
Út	30–45 min	Traumatologický pacient: RTG snímek, eFAST a CT společně. Případ 87.	Svazek 06 · 100 praktických případů
Stř	30–45 min	Neurologická urgence: od CT k MR. Případ 88.	Svazek 06 · Multimodální případy
Čt	30–45 min	Náhlá příhoda břišní: od UZ k CT. Případ 89.	Svazek 06 · Atlas nejčastějších nálezů
Pá	30–45 min	Scénáře bolesti na hrudi a dušnosti. Případ 90.	Svazek 06 · Průvodce interpretací snímků
So	30–45 min	Případ 91, sebehodnocení, formulace hlášení urgentních nálezů.	Cvičebnice

5 případů tohoto týdne (100 praktických případů)

Případ 87 · Případ 88 · Případ 89 · Případ 90 · Případ 91

Víkendové sebehodnocení

- [ ] Nezapomínám u případu porovnat předchozí vyšetření a ostatní modality.
- [ ] Dokážu syntetizovat nálezy z různých modalit do jednoho závěru popisu.
- [ ] Dokážu vyjmenovat seznam nálezů, které musím ve službě urgentně hlásit.
- [ ] Zvykl(a) jsem si v případě nejistoty konzultovat nález se svým školitelem a zaznamenat to.
- [ ] Mé doporučení přímo odpovídá na klinickou otázku.

TÝDEN 12

Celkové opakování a simulace vizity

Shrnutí dvanácti týdnů: popište každý případ tak, jako byste jej prezentovali na vizitě.

Cíl týdne

Automaticky aplikovat 4 kroky u všech modalit; dokázat odprezentovat případ během 60 sekund v pevné struktuře a s jasným závěrem popisu.

DEN	ČAS	ÚKOL	MATERIÁL
Po	30–45 min	Opakování RTG: vaše poznámky v sešitě; Případ 96.	Svazek 02 · Cvičebnice · 100 praktických případů
Út	30–45 min	Opakování CT; Případ 97 ústní prezentace.	Svazek 03 · 100 praktických případů
Stř	30–45 min	Opakování MR; hlasitá prezentace Případu 98.	Svazek 04 · Abeceda obrazu
Čt	30–45 min	Opakování UZ a POCUS; Případ 99.	Svazek 05 · Atlas nejčastějších nálezů
Pá	30–45 min	Simulace vizity: multimodální případ s měřením času. Případ 100.	Svazek 06 · Průvodce interpretací snímků
So	30–45 min	Sebehodnocení; napište si plán na druhé období.	Cvičebnice · Týdenní záznamový arch pokroku

5 případů tohoto týdne (100 praktických případů)

Případ 96 · Případ 97 · Případ 98 · Případ 99 · Případ 100

Víkendové sebehodnocení

- [ ] U každé modality dokážu říct svůj postup hodnocení bez nahlížení do papíru.
- [ ] Dokážu prezentovat případ během 60 sekund ve fixní struktuře.
- [ ] Můj závěr popisu, diferenciální diagnóza a doporučení jsou součástí každého případu.
- [ ] Určil jsem si témata, která mi dělají potíže, a zařadil je do prvních týdnů druhého období.
- [ ] Vypsal jsem si čísla nevyřešených případů ze 100 praktických případů pro druhé kolo.

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Otevřete dnes Svazek 01 · Fyzikální abeceda a začněte pondělním úkolem 1. týdne. Prvních 30 minut určuje rytmus zbytku roku.

Otázky odpovídající tématu každého týdne pro přípravu na vizity **300 otázek k vizitám a ústním zkouškám**pracujte v něm; svůj pokrok **Týdenní záznamový arch pokroku**zaznamenejte do něj.